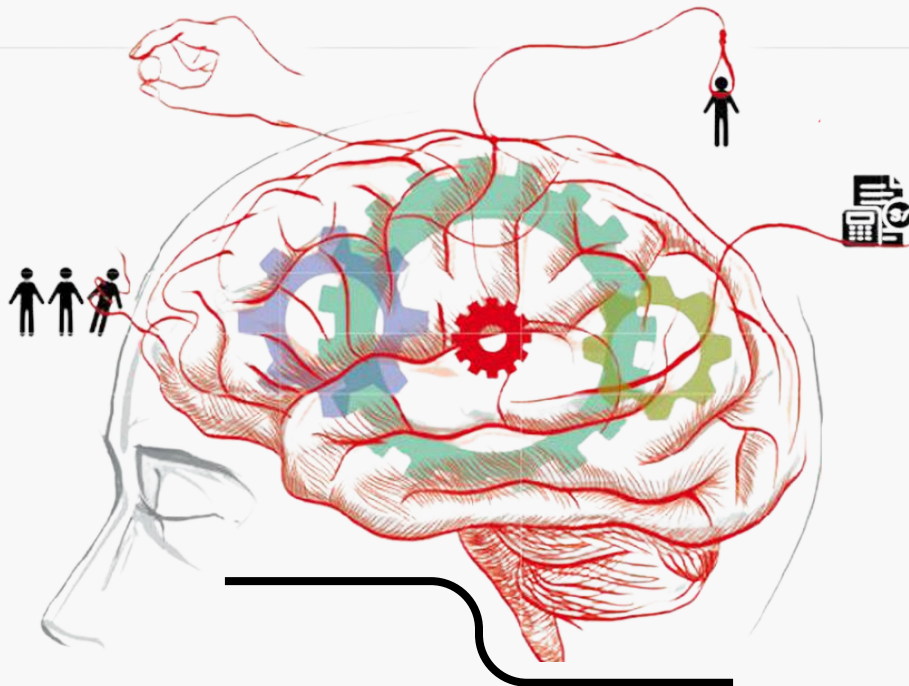




ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE SALUD MENTAL EN EL PERÚ

DETECCIÓN TEMPRANA Y MAPEO DE ZONAS VULNERABLES

LINK DEL DRIVE

INTEGRANTES

Alcantara Flores, Diego Rafael
Ramirez Condor, Anahis ABigial
Soplopuco Vilchez, Karen Crhistel

CONTENIDO

PROBLEMÁTICA	01	¿Qué grupos poblacionales presentan mayor riesgo emocional?	05
DATOS, SALUD Y DECISIONES: EL PANORAMA CLÍNICO A NIVEL NACIONAL	02	¿Cómo se distribuye la demanda de atención entre los diferentes tipos de seguro?	06
OBJETIVOS DEL PROYECTO	03	¿Cómo se relacionan los factores de riesgo psicosocial, hábitos de vida y características demográficas con los niveles de salud mental de los pacientes”?	07
¿Cómo se distribuyen los problemas de salud mental y el riesgo suicida en las diferentes provincias del Perú?	04	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	08



PROBLEMATICA



Problemática de la Gestión y Análisis de Diagnósticos Clínicos en Salud Pública

Los diagnósticos clínicos constituyen una fuente esencial de información para comprender el estado de salud de la población, especialmente cuando se busca identificar tempranamente condiciones que podrían agravarse si no se actúa a tiempo. Sin embargo, en muchas regiones del país, esta información no es analizada de manera sistemática, lo que dificulta la detección de patrones, la ubicación de zonas vulnerables y la toma de decisiones oportunas por parte de los servicios de salud.

63.8 %

Un estudio realizado en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (Lima) analizó 450 historias clínicas y encontró que el 63,8 % presentaba pérdida de información, ya sea por registros incompletos o historias no localizadas. Esto evidencia la dificultad para contar con datos clínicos completos y confiables, lo que limita la identificación de áreas críticas y poblaciones vulnerables.

Este problema se agrava por cuatro desafíos principales:

- No se identifican bien a las poblaciones en riesgo porque falta un análisis claro que muestre qué grupos necesitan más atención.
- No se pueden anticipar aumentos de demanda, lo que genera sobrecarga en los centros de salud por falta de alertas y seguimiento de tendencias.
- La información no se visualiza ni monitorea en tiempo real, ya que los reportes son estáticos y no permiten detectar patrones ni comparar periodos fácilmente.
- Los datos están dispersos y sin integrar, lo que impide un análisis completo y dificulta reconocer tendencias o zonas vulnerables.



DATOS, SALUD Y DECISIONES: EL PANORAMA CLÍNICO A NIVEL NACIONAL

Este informe analiza 20 mil registros clínicos recopilados en diversas regiones del país, con el objetivo de comprender mejor la situación de la salud pública mental. A través de gráficos e indicadores clave, se identifican patrones y zonas de mayor riesgo que permiten reconocer poblaciones vulnerables y orientar acciones preventivas. Esta información facilita una toma de decisiones más precisa y contribuye a mejorar la gestión sanitaria en un contexto dinámico y en constante cambio.

Cantidad total de pacientes

20,000



OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema de análisis estadístico y visualización que permita integrar, procesar e interpretar los registros de diagnósticos de salud mental, con el fin de identificar tempranamente patrones, grupos vulnerables y zonas de riesgo, mejorando la toma de decisiones y la planificación de intervenciones preventivas.



OBJETIVOS ESPECIFICOS



Consolidar y depurar los registros clínicos,

Realizando análisis descriptivos y comparativos para identificar tendencias por edad, sexo, ubicación y tipo de enfermedad mental.



Detectar áreas geográficas vulnerables y generar indicadores clave

Como evolución anual de casos y grupos más afectados, mediante mapas temáticos y análisis espacial para identificar zonas con mayor concentración o riesgo.



Desarrollar visualizaciones interactivas y recomendaciones

permitiendo un monitoreo dinámico y orientando mejoras en atención, prevención y asignación de recursos.

¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y EL RIESGO SUICIDA EN LAS DIFERENTES PROVINCIAS DEL PERÚ?

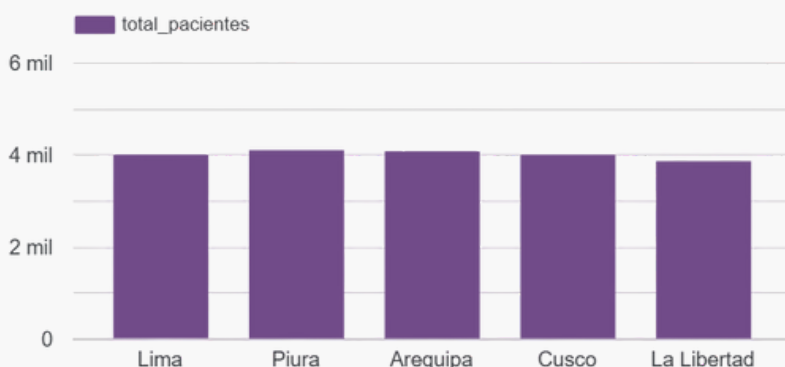
Distribución del Riesgo Suicida

riesgo_suicida ▾	casos_atendidos ▾
Bajo	6732
Medio	6714
Alto	6554

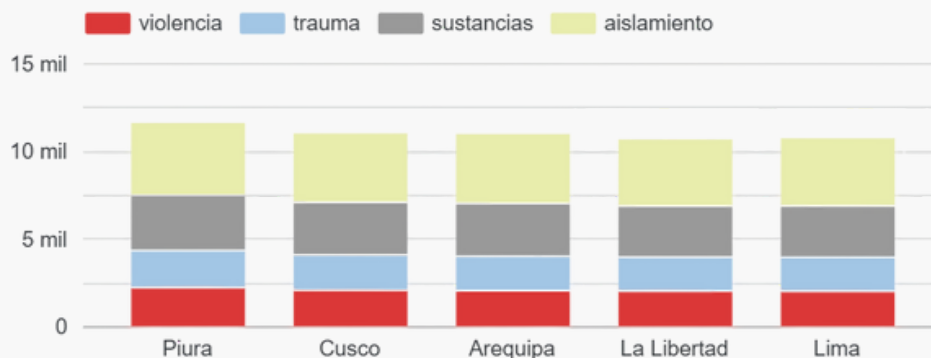
Esto muestra que la mayoría de pacientes no está en riesgo mínimo, sino en niveles que requieren atención activa. Tener un alto porcentaje en “Medio” indica presencia de pensamientos o conductas de riesgo que no se pueden ignorar.

La mayor cantidad de pacientes atendidos se concentra en Lima, Piura y Arequipa, lo que evidencia una demanda más alta en estas regiones. Este escenario destaca la necesidad de priorizar recursos y fortalecer la capacidad operativa en dichas zonas para mejorar la atención en salud.

Total de Pacientes por Provincia



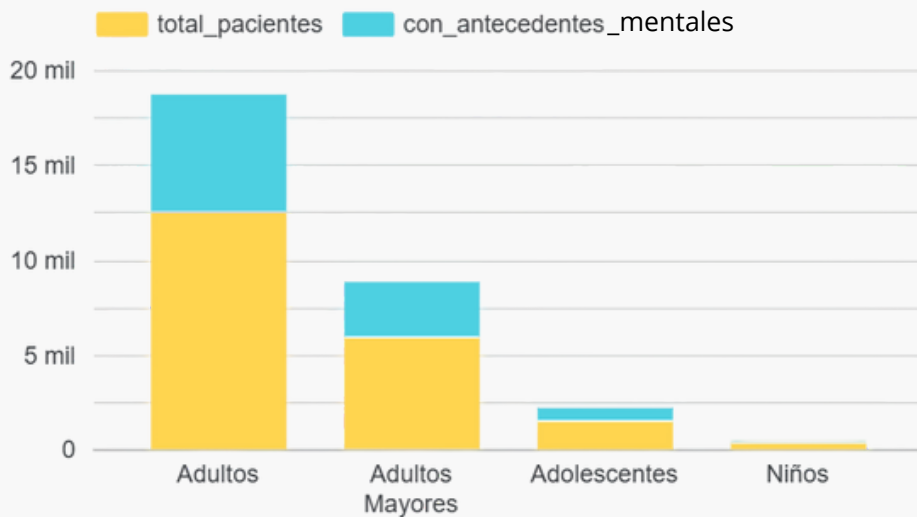
Tipo de Casos Atendidos por Provincia



El aislamiento es la problemática más frecuente en todas las provincias, reflejando dificultades en la integración social y acceso a redes de apoyo. Además, se observa un patrón similar entre regiones, lo que indica que las necesidades en salud mental comparten características comunes a nivel regional.

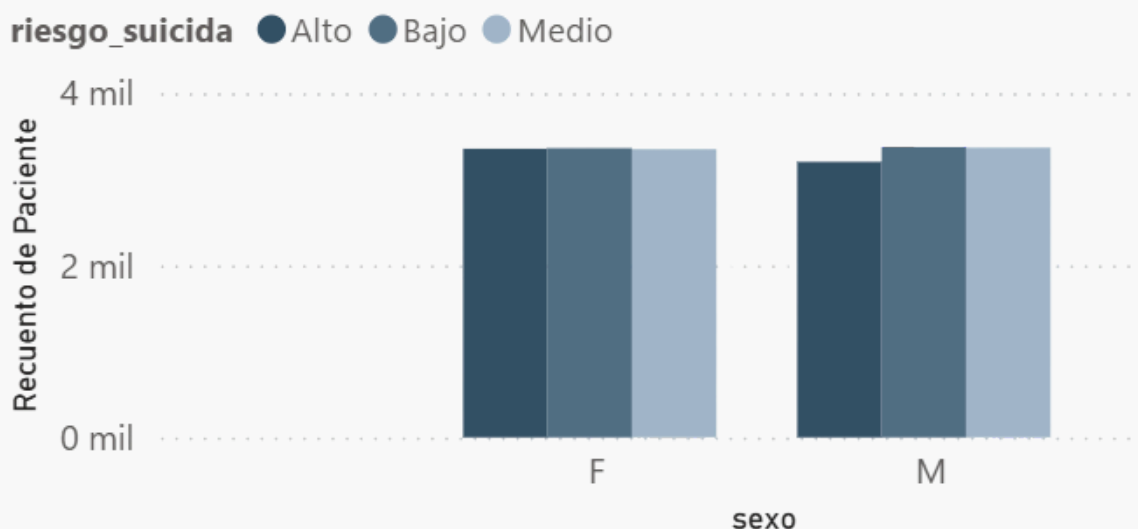
¿QUÉ GRUPOS POBLACIONALES PRESENTAN MAYOR RIESGO EMOCIONAL?

Grupos etarios más vulnerables con antecedentes mentales:



Los adultos son el grupo con mayor cantidad de pacientes atendidos y con más registros de antecedentes mentales, lo que evidencia una mayor vulnerabilidad en este segmento. Por ello, la población adulta requiere atención e intervenciones prioritarias en salud mental.

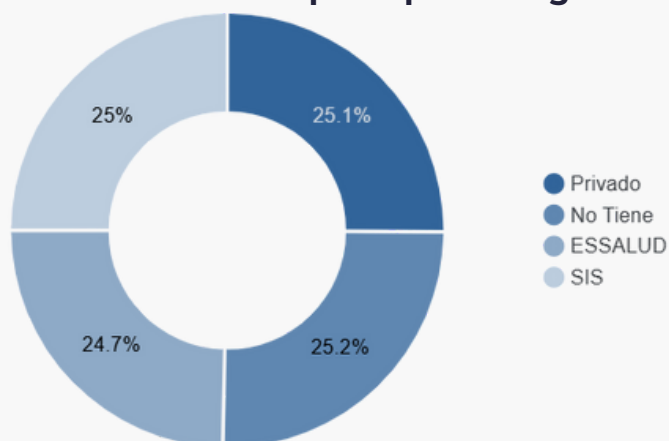
Niveles de riesgo suicida en pacientes atendidos recientemente según sexo



Hombres y mujeres presentan un número similar de pacientes atendidos recientemente. En ambos sexos predomina el riesgo suicida Alto, seguido del Medio y el Bajo. Esto sugiere que la vulnerabilidad frente al riesgo suicida es elevada y no muestra diferencias significativas entre sexos, lo que indica que las acciones de prevención e intervención en salud mental deben plantearse de manera integral y dirigida a toda la población atendida, sin enfocarse exclusivamente en un solo sexo.

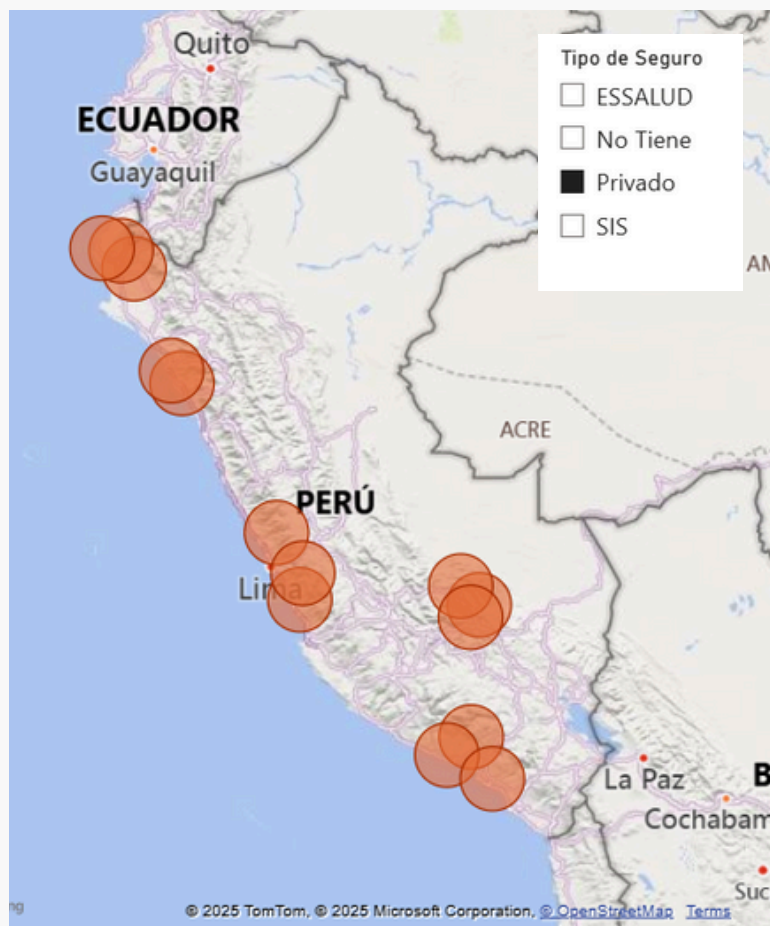
¿CÓMO SE DISTRIBUYE LA DEMANDA DE ATENCIÓN ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS DE SEGURO?

Casos Atendidos por Tipo de Seguro



La distribución de casos atendidos por tipo de seguro (Privado, No Tiene, ESSALUD y SIS) es bastante equilibrada, con cada grupo representando aproximadamente el 25% del total. Esto indica que los problemas de salud mental afectan de manera similar a personas con o sin seguro, mostrando que la demanda de atención es transversal al tipo de aseguramiento.

Distribución de pacientes atendidos por Provincia



Este mapa interactivo muestra la distribución geográfica de pacientes atendidos en salud mental en las provincias del Perú. El tamaño de cada burbuja es proporcional al número de pacientes registrados en cada provincia y atendidos según su tipo de seguro.

Al utilizar el filtro por 'Tipo de Seguro', es posible seleccionar uno o más grupos para observar cómo varía la demanda de atención según la cobertura del seguro de los pacientes. Esta herramienta facilita visualizar en qué provincias hay mayor concentración de pacientes por tipo de seguro, lo cual es fundamental para dirigir mejor los recursos y planificar los servicios de salud mental donde más se requieren.

¿CÓMO AFECTA LA PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL A LA GRAVEDAD DE LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL Y AL RIESGO SUICIDA EN LOS PACIENTES ATENDIDOS?

Relación entre violencia y nivel de depresión

	nivel_depresion	total_casos_violencia
1.	2	985
2.	0	965
3.	5	950
4.	7	970
5.	9	1037
6.	1	1041
7.	6	1003
8.	3	983
9.	0	900

1 - 10 / 10 < >

La violencia está presente en pacientes de todos los niveles de depresión, desde leve hasta severa, con más de 900 casos en cada nivel. Esto confirma que la violencia es un factor psicosocial relevante que afecta ampliamente la salud mental, indicando la necesidad de intervención y apoyo emocional en toda la población.

Total de paciente que cuentan con Depresión y riesgo suicida:

	nivel_depresion	riesgo-suicida	total
1.	2	Bajo	1.976
2.	8	Alto	1.999
3.	0	Bajo	1.935
4.	4	Bajo	1.994
5.	9	Alto	2.057
6.	5	Medio	2.015
7.	3	Bajo	2.032

1 - 10 / 10 < >

El nivel de depresión alto concentra la mayor cantidad de pacientes (2.057), lo que incrementa significativamente el riesgo de suicidio. Este grupo requiere atención prioritaria, estrategias preventivas y monitoreo constante, reforzando la importancia de la detección temprana y el tratamiento oportuno.

CONCLUSIONES



La mayoría de pacientes llega con depresión en niveles altos, esto indica que muchas personas no buscan ayuda cuando los síntomas son leves, sino cuando el problema ya es difícil de manejar. Esto puede deberse al miedo, vergüenza, falta de información o porque no reconocen los síntomas a tiempo.

Los niveles intermedios de depresión (leve y moderada) muestran valores relativamente estables, sin fluctuaciones críticas a lo largo de la base analizada. Esto demuestra que el principal impacto asistencial y clínico recae en los casos graves, que concentran la mayor carga de atención.

Los resultados evidencian una demanda constante de atención en salud mental, lo que obliga a fortalecer la capacidad operativa de los centros asistenciales, tanto en recurso humano como en infraestructura, para evitar sobredemanda y garantizar la calidad terapéutica.

El análisis demuestra que distintos tipos de seguro (público, privado o sin cobertura) presentan distribuciones similares, lo que confirma que los problemas de salud mental afectan a la población sin distinción socioeconómica. Esto refuerza la necesidad de políticas inclusivas y sostenibles en el tiempo.

Los adultos son el grupo más afectado, la mayor parte de los casos registrados pertenece a adultos. Esto podría explicarse porque en esta etapa se enfrentan responsabilidades como trabajo, familia, deudas, estrés laboral y problemas sociales que aumentan el riesgo de depresión.

El uso de herramientas de Big Data, como BigQuery, Looker Studio, Python y Power BI, demostró ser útil para identificar patrones, tendencias y poblaciones críticas, aportando información clave para la toma de decisiones clínicas y administrativas basadas en evidencia.

RECOMENDACIONES



Priorizar atención a pacientes con depresión severa por su alto riesgo de suicidio, y detectar tempranamente casos leves y moderados para evitar su progresión.

Fortalecer seguimiento continuo, especialmente en casos de alto riesgo, mediante acompañamiento periódico.

Desarrollar programas comunitarios de prevención que promuevan apoyo social, reducción del aislamiento y fortalecimiento de habilidades psicosociales.

Automatizar la carga y limpieza de datos en BigQuery para contar con información actualizada en tiempo real y facilitar la respuesta rápida.

Implementar modelos predictivos de riesgo usando estadísticas o Machine Learning para anticipar áreas, semanas o grupos con alta probabilidad de depresión severa.

Crear dashboards diferenciados por población (adolescentes, adultos, adultos mayores, pacientes con riesgo suicida) para orientar intervenciones específicas. Además: Evolucionar hacia una plataforma de monitoreo continuo y predictivo que permita visualizar tendencias, identificar zonas críticas y anticipar crisis emocionales.

